

Évaluation du portage bactérien manuel chez le personnel soignant en milieu hospitalier:

Urgence d'une optimisation de l'hygiène hospitalière



I.Guellati 1, F. Sahli 1.2

1 Laboratoire de microbiologie médicale, Centre Hospitalo-Universitaire SAADNA ABDENOUR Sétif, Algérie.

1.2 Laboratoire de microbiologie médicale, Centre Hospitalo-Universitaire SAADNA ABDENOUR. Université Ferhat Abbas 1, Sétif, Algérie.

gue.imene@yahoo.fr

CBMS 2026



Introduction

Les infections associées aux soins constituent un problème majeur en milieu hospitalier, particulièrement lors des procédures invasives. Les mains du personnel soignant représentent un vecteur essentiel de transmission croisée des micro-organismes. L'identification des bactéries colonisant les mains ainsi que l'étude de leur sensibilité aux antibiotiques permettent d'évaluer le risque de transmission de germes potentiellement pathogènes ou résistants. L'évaluation microbiologique de l'hygiène des mains constitue ainsi un outil pertinent pour identifier les insuffisances et proposer des mesures correctives adaptées.

Objectif

Évaluer le niveau d'hygiène des mains du personnel soignant à travers l'identification des micro-organismes colonisateurs et la mesure de leur sensibilité aux antibiotiques, afin de proposer des mesures correctives adaptées

Matériel et Méthodes



Fig.1: Culture des empreintes digitales sur milieu GSC

- Une enquête bactériologique descriptive transversale a été menée le 25 février 2026 au niveau d'un service au sein du CHU de Sétif.
- Quatre prélèvements par empreintes digitales du personnel soignant ont été réalisés. (Fig1)
- L'identification bactérienne a été réalisée par les méthodes classiques du diagnostic bactériologique, la mesure de la sensibilité aux antibiotiques a été effectuée par antibiogramme standard selon les recommandations du CLSI.

Résultats

- Sur les 4 prélèvements analysés, une flore diversifiée a été isolée. (Fig.2)
- Micrococcus spp* a été retrouvé de manière constante (4/4).
- Des germes à haut potentiel pathogène et opportuniste ont été mis en évidence : *Staphylococcus saprophyticus* méticillino-résistant (Fig.3) chez un soignant, *Staphylococcus* à coagulase négative associé à *Enterobacter cloacae* (Fig.4) chez un autre.
- Le taux de positivité pour les bactéries à pouvoir pathogène direct ou nosocomial strict s'élève à 50% des personnels prélevés (Fig.5).

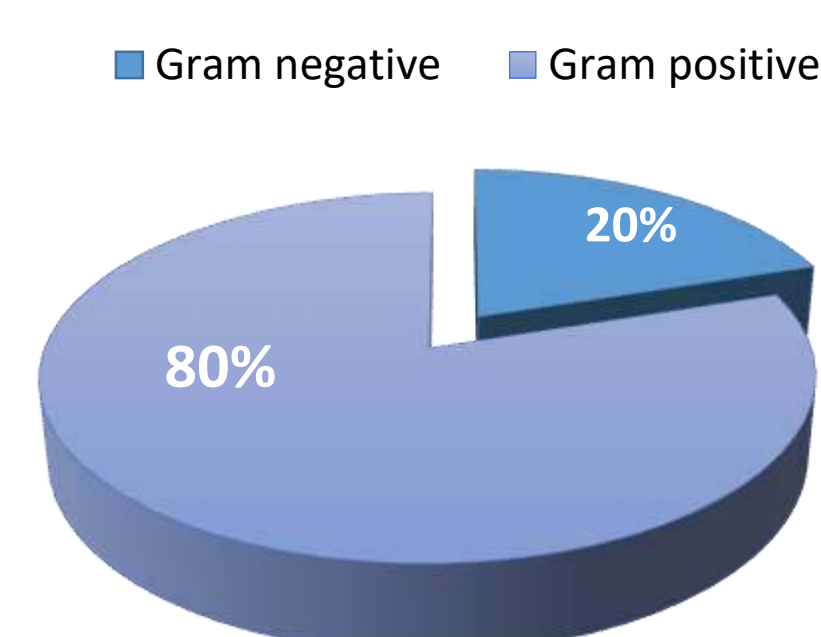


Fig.2: Bactéries isolées des empreintes digitales

Personnel soignant	Résultats
I	<i>Micrococcus spp</i>
R1	<i>Micrococcus spp</i> <i>Staphylococcus saprophyticus</i> méticillino-résistant
R2	<i>Micrococcus spp</i>
MA	<i>Staphylococcus</i> à coagulase négative <i>Micrococcus spp</i> <i>Enterobacter cloacae</i>

Fig.5: Résultats de l'étude bactériologique.



Fig.3: *Staphylococcus saprophyticus*



Fig.4: *Enterobacter cloacae*

Discussion

- Les infections associées aux soins (IAS) constituent un problème de santé publique mondial. Plusieurs études indiquent que l'amélioration de l'observance de l'hygiène des mains (HM) est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les IAS. Cependant, l'observance de l'hygiène des mains reste insuffisamment documentée.
- La propagation de ces germes dans les unités est principalement médiée, d'une part, par le personnel soignant (transmission essentiellement manuportée) et, d'autre part, par l'environnement. (1)
- Nos résultats rejoignent ceux rapportés dans une étude(2) portant sur 60 prélèvements, ayant permis d'isoler 102 souches bactériennes et de mettre en évidence une diversité importante de microorganismes. Cette étude a notamment rapporté la présence de *Staphylococcus aureus*, de *Pseudomonas spp.*, d'*Escherichia coli*, de *Klebsiella spp.* Dans notre étude, la présence d'un *Staphylococcus saprophyticus* méticillino-résistant ainsi que l'association d'un *Staphylococcus* à coagulase négative avec *Enterobacter cloacae* témoigne également de la présence de bactéries potentiellement pathogènes ou opportunistes sur les mains du personnel soignant.
- La représentativité de nos résultats peut être limitée par le faible nombre d'échantillons analysés. Cette limitation est principalement liée à une disponibilité insuffisante des milieux de culture durant la période d'étude, ce qui a restreint le nombre de prélèvements réalisés.

Conclusions

L'isolement de bactéries opportunistes multi-résistantes et d'entérobactéries met en évidence des insuffisances manifestes dans l'application des protocoles d'hygiène des mains. Bien que l'échantillonnage soit limité par la disponibilité des milieux de culture, ces signaux d'alerte imposent un renforcement immédiat des mesures de friction hydro-alcoolique et un suivi microbiologique régulier.



Références

- (1) A. Schmand, M. Tran, B. Pilmis, C. Bruel, F. Philippart. *Infections nosocomiales : conduite à tenir et stratégie thérapeutique devant une épidémie*. [36-984-A-30] - Doi : 10.1016/S0246-0289(20)88857-4
- (2) M.A.Ahmed, S.M.Hussein, G.K.M khairy Al-hindawi, R.A.Ali: *Isolation And Identification of Bacteria from The Staff Hands of Yarmouk Teaching Hospital, Baghdad, Iraq*. Vol. 11 No. 08 (2025): Volume11 Issue 08 | Pages: 126-131 | <https://doi.org/10.55640/ijmsdh-11-08-17>